

TEMA 4.3 • DERMATOLOGÍA

Exantemas Eritematodescamativos

PERFIL EUNACOM 6.01.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Exantemas Eritematodescamativos Multi-placa

Las erupciones cutáneas agudas presentadas como un difuso "exantema" que mezcla enrojecimiento y descamación, suponen un delicado diagnóstico diferencial topográfico basado netamente en la distribución de las micromanchas.

1. Psoriasis Guttata (En Gotas)

- **Etiología:** A diferencia de la psoriasis clásica vulgar autoinmune idiopática, la Guttata posee un inmenso y reconocible **gatillante Post-Infeccioso** (Patognomónico antecedente de Infección Amigdalitis faríngea bacteriana aguda Estreptocócica previa de un par de semanas previas). - **Clínica Morfológica:** Lluvia aguda de innumerables placas eritematodescamativas macizas **puntiformes pequeñas (Menores a 1 centímetro, semejando "Gotas" rojas esparcidas de agua)**. - **Distribución:** Masiva y diseminada por tronco, cara, dorso y caras extensoras. - **Signo Diferencial Cardinal Excluyente: Respeta y exime completamente a las Palmas y Plantas.** - **Tratamiento Puntero:** Remite rápido y espectacularmente con sesiones puntuales de **Fototerapia UVB**. Si fracasa, se rotaría al esquema psoriasis tradicional en crema sintomática.

2. Pitiriasis Rosada (Enfermedad de Gibert)

"Pitiriasis" proviene de descamación / caspa. - **Etiología:** Infección Sistémica de reactivación viral por **Virus Herpes Humano tipo 6 y 7 (VHH-6, VHH-7)**. Posee el mismo agente causal pediátrico que el famoso "Exantema Súbito / Roséola Infantum" que atacaba preescolares c/ fiebres altísimas. En el adulto sano despunta silente, eutérmico (Sin fiebre) y focalizando su manifestación local como este rash. - **Clínica Morfológica Cronológica:** 1. **Fase Inicial:** Emerge una placa central anular eritematodescamativa grande única, bautizada popularmente la **"Mancha Heráldica o Placa Mensajera"** (Avisando ser la pionera mensajera de lo que vendrá la próxima semana). 2. **Fase Secundaria Cutánea:** Dos semanas posterior a la placa madre, estalla la lluvia de micro placas color salmón/rosado en collarate descamativo. - **Distribución Patognomónica:** Abarcan tórax, espalda y abdomen, respetando cara y partes pélvicas distales, pero dibujando un acomodo de distribución celular simétrica obligada paralela siguiendo los arcos costales traseros formando el **Signo del Árbol de Pascua o Pino de Navidad Central**. - **Tratamiento:** Simple y pura **Observación pasiva educacional**. El rash cursa un proceso autolimitado benigno larguísimo que tardará frustrantemente de **2 a 3 Meses** en despintarse por si solo. Si llegase a exacerbar mucho prurito molesto por reacción inmunológica, el único sustento recetado es el **Antihistamínico para alergia (Cetirizina/Loratadina)**.

3. Sífilis Secundaria (El Lúes Exantemático)

- **Etiología:** Estadio bacteriémico diseminado sistémico avanzado no diagnosticado tempranamente por penetración del espiroqueta

chancro genital de la bacteria etiológica **Treponema Pallidum**. - **Clínica Morfológica Diferencial Suprema:** El característico rash de escaso o confuso prurito se plasma bajo el aspecto popular en medicina de las temidas ronchas exantemáticas eritematosas **"Ajamonadas / Color piel de Jamón o Mortadela cocida"**. - **Topografía Excluyente Diagnóstica:** Tiene afinidad anatómica altísima y perentoria por brotar y acibillar obligadamente las regiones corneodérmicas gruesas: **Palmas de las Manos y Plantas de los Pies**. (Brote que se asocia también con adenopatías y placas alopecia en mordida de ratón secundarias en cuero cabelludo paralelo). - **Diagnóstico Laboratorio EUNACOM:** Al sospechar el médico el rash, exigirá inmediato un Test no treponémico de tamizaje Screening cuantificado (**VDRL / RPR positivos en títulos inmensamente diluidos >1:16**), los cuales si reaccionan deben corroborarse posteriormente por el confirmatorio estricto *Test Treponémico FTA-ABS*. La medicina pragmática dice: Frente a un Screening en mano VDRL reaccional y lesión en palma de sospecha firme, no espere semanas el cruce complejo e inicie el tratamiento erradicador preventivo de inmediato. - **Tratamiento Único Curativo Eleccionario: Inyección Intramuscular potente en Nalgas de Penicilina G Benzatina a dosis de 2.4 Millones de Unidades Internacionales (Toma Única simple).**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál de estas tres enfermedades eritematodescamativas afecta específicamente palmas y plantas?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Exantemas Eritematodescamativos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La psoriasis gutata aparece postinfección estreptocócica y produce gotas menores a un centímetro.
- La psoriasis gutata respeta palmas y plantas, a diferencia de la sífilis secundaria que las afecta.
- La pitiriasis rosada de Gilbert comienza con la mancha eráldica antes que la erupción generalizada.
- La pitiriasis rosada sigue distribución en árbol de navidad y es autolimitada en dos a tres meses.
- La sífilis secundaria afecta palmas y plantas con lesiones de color jamón, siendo un hallazgo patognomónico.
- El tratamiento de la sífilis secundaria es penicilina benzatínica dos coma cuatro millones IM en dosis única.
- La fototerapia NB-UVB es el tratamiento de elección para la psoriasis gutata.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (EXANTEMAS ERITEMATODESCAMATIVOS)**PREGUNTA 1**

¿Cuál de estas tres enfermedades eritematodescamativas afecta específicamente palmas y plantas?

- A)** La psoriasis gutata postinfecciosa
- B)** La pitiriasis rosada de Gilbert por VHH-6
- C)** La sífilis secundaria por *Treponema pallidum*
- D)** La dermatitis seborreica del adulto
- E)** El exantema vírico inespecífico postinfeccioso

PREGUNTA 2

¿Cómo se llama la lesión inicial característica de la pitiriasis rosada de Gilbert?

- A)** El placón eritemato-descamativo de gran tamaño
- B)** La mancha eráldica o heraldo que aparece días antes de la erupción
- C)** La gota psoriasiforme que precede al exantema generalizado
- D)** La lesión en diana con centro pálido típica del eritema multiforme
- E)** La ampolla tensada que marca el inicio del cuadro clínico

PREGUNTA 3

¿Cuál es el tratamiento de la sífilis secundaria?

- A)** Doxiciclina oral por catorce días en dosis de cien miligramos dos veces al día
- B)** Fototerapia NB-UVB en sesiones tres veces por semana durante dos meses
- C)** Penicilina benzatínica dos coma cuatro millones de unidades IM en dosis única
- D)** Aciclovir oral seiscientos miligramos al día por diez días consecutivos
- E)** Corticoides tópicos de alta potencia dos veces al día por cuatro semanas

RESUMEN: EXANTEMAS ERITEMATODESCAMATIVOS

Los exantemas eritematodescamativos incluyen tres enfermedades importantes que hay que saber diferenciar entre sí y de la psoriasis. La psoriasis gutata o en gotas aparece típicamente postinfección estreptocócica faríngea, con lesiones en forma de gotas menores a un centímetro distribuidas por el tronco y extremidades, respetando palmas y plantas, y se trata con fototerapia de banda estrecha NB-UVB. La pitiriasis rosada de Gilbert es una enfermedad autolimitada causada por el virus herpes humano seis y siete, que comienza con una mancha eráldica o heraldo de mayor tamaño, seguida días después por erupción generalizada en el tronco con distribución en árbol de navidad siguiendo las líneas de tensión, respetando cara y extremidades, y se resuelve espontáneamente en dos a tres meses. La sífilis secundaria es la más importante de recordar porque afecta palmas y plantas, a diferencia de las otras dos, con lesiones de color jamón o cobre que son siempre indoloras e indolentes, y se trata con penicilina benzatínica dos coma cuatro millones de unidades intramuscular en dosis única.